BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) — ZELO: TECNOLOGIA QUE CUIDA
Programa: AKCIT Camp Multicêntrico 2026 (Etapa Nordeste — Recife/PE)

1. Segmento de Clientes

Compradores / Contratantes (B2G): Prefeituras e Secretarias Municipais de Saúde.
Usuários Finais (Acesso 100% Gratuito): Cidadãos dependentes do SUS, com foco prioritário em idosos, trabalhadores com demandas urgentes (ex.: exames admissionais), gestantes e pessoas neuro divergentes.
Operadores Internos: Recepcionistas de UBS, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Coordenadores da Atenção Primária.

2. Proposta de Valor

Para o Cidadão: Previsibilidade operacional em tempo real e dignidade no acesso à saúde. Fim das viagens perdidas (por falta de serviços específicos na unidade ou reuniões/ausências não avisadas) e eliminação das filas de madrugada nas calçadas.
Para a Gestão Pública: Visibilidade em tempo real da demanda reprimida, redução do absenteísmo, desafogamento das recepções e otimização da alocação de equipes sem depender de integrações pesadas com sistemas legados.

3. Canais

Digital Acessível: Aplicação Web Mobile-First (com adaptação automática de interface para idosos e neuro divergentes) e canal conversacional via WhatsApp.
Presencial / Territorial: Balcão de recepção das UBSs e suporte direto pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) nas visitas domiciliares.

4. Relacionamento com Clientes

Com o Cidadão: Acolhimento humanizado em linguagem natural simples via Agente de IA, com alertas proativos antes do deslocamento.
Com Prefeituras: Implantação assistida, painel contínuo de indicadores operacionais e suporte técnico dedicado às unidades.

5. Fontes de Receita

Licenciamento SaaS B2G: Assinatura anual contratada por municípios, precificada por faixa populacional e quantidade de UBSs ativas na rede.
Inovação Aberta e Convênios: Captação via editais públicos de saúde digital e parcerias institucionais (operação totalmente gratuita para o cidadão).

6. Recursos Principais

Arquitetura Multiagente: Orquestração inteligente combinando RAG (matriz oficial de serviços por UBS) e Function Calling (consulta de status operacional ao vivo e reserva de vagas).
Base Proprietária de Operação: Dados em tempo real alimentados de forma leve pela ponta (status de salas de vacina, presença médica e janelas reais de atendimento).

7. Atividades-Chave

Desenvolvimento, calibração e monitoramento dos agentes de IA e seus guardrails éticos/clínicos.
Sincronização operacional simplificada com as equipes de recepção das UBSs e análise de métricas de impacto para os gestores municipais.

8. Parcerias Principais

Secretarias Municipais de Saúde e Consórcios Intermunicipais.
Ecossistemas de inovação e infraestrutura tecnológica (AKCIT, CEIA, AWS e Porto Digital).
Associações comunitárias e conselhos locais de saúde para validação contínua.

9. Estrutura de Custos

Infraestrutura de IA e Nuvem: Consumo de APIs de LLMs (tokens de inferência), servidores em nuvem (AWS) e armazenamento seguro.
Segurança e Conformidade: Adequação rigorosa à LGPD, anonimização de dados e manutenção de software.
Operação e Implantação: Equipe técnica, suporte operacional e capacitação rápida das equipes das unidades.

Métricas-Chave de Impacto (KPIs)

1. Viagens perdidas evitadas (usuários barrados antes de ir a unidades sem o serviço ou em reunião).
2. Redução no tempo médio de espera externa nas filas de madrugada.
3. Taxa de resolução autônoma dos agentes (consultas respondidas e remanejamentos concluídos sem intervenção humana).